جوستاف روسي انترناشيونال - مصر (EPE) *

طلب علاج أول مرة / متردد

إسم المريض رباعياً : منال سعيد زين العابدين
المحافظة : القاهره **الحي / المدينة :** مدينه السلام **العنوان :** 0
رقم البطاقة : 27703260104406 **رقم التليفون :** 01119948574 **تاريخ تسجيل الإستمارة :** 17-10-2026
العمر(تاريخ الميلاد) : 26-03-1977 **المهنة :** ربه منزل

الإقرار

أقر انا الموقع أدناه انني لا اتمتع باي نظام علاج مثل:-التأمين الصحي-القوات المسلحه-الشرطة-الهيئات-المؤسسات او اي نظام يتعارض مع نظام العلاج علي نفقة الدولة- وسوف اتحمل كافة نفقات العلاج في حالة ثبوت غير ذلك

الإخصائي الاجتماعي **المقر بما فيه**
التوقيع:(----------) **التوقيع:**(----------)

التشخيص الإكلينيكي : سرطان بالثدي (مبادرة)
نتائج الأبحاث : (مرفق)
التشخيص النهائي : سرطان بالثدي (مبادرة)
خطة العلاج : أبحاث أورام تصوير مقطعي للصدر والبطن والحوض بالصبغة [11129] **قسم العلاج :** الاورام
التعليق على التشخيص : ----------

تقرير اللجنة الثلاثية المتخصصة

الاسم: د/محمد كيلاني **الوظيفة:** ---------- **التوقيع:** ----------
الاسم: د/ندى حسن **الوظيفة:** ---------- **التوقيع:** ----------
الاسم: د/نرمين رمضان **الوظيفة:** ---------- **التوقيع:** ----------

أطلعت اللجنة علي لائحة العلاج الخاصة بالمجالس وتلتزم جهة العلاج بلائحة المجالس الطبية.
كما تقر اللجنة بأن البيانات المدونة فى هذا النموذج صحيحة.

تعتمد صحة البيانات المرفقة
رئيس اللجنة و مدير المستشفي.

تتعهد المستشفى أن لا يتم تنفيذ القرار إلا بعد مراجعة الملف الطبي للمريض وإعادة مناظرة المريض بالمستشفي قبل الصرف.

أعضاء اللجنة

ا.د/ ---------- **ا.د/** ---------- **د/** ---------- **د/** ----------

قرار اللجنة

التشخيص النهائي : ----------
خطة العلاج : ----------
المستشفي : ----------**قسم :** ----------
جهة العلاج : ----------**نفقات :** ----------
ملاحظات : ----------

رئيس	مدير عام	ختم
المجلس الطبي المتخصص	مديرية الشئون الصحية	شعار الجمهورية

Name: منال سعيد زين العابدين
National ID: 27703260104406

تقرير طبي

السيد

تحية طيبة وبعد,,

إيماء للطلب المقدم من	**بشأن تقرير طبي للمريض**
بقسم:	**رقم طبي:**

نتشرف بأن نوضح فيما يلي تقريرا عن حالته

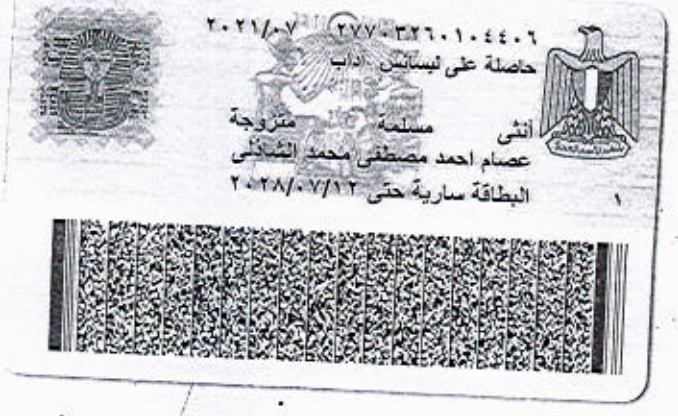
تاريخ وساعة الدخول : -- --:-- yyyy-mm-dd	**تاريخ وساعة الخروج :** PM 01:17 05-07-2026

وبعد الكشف والفحوصات والمتابعة وجد انة

المريضة تعاني من ورم غير حميد بالثدى و تحتاج الي **Contrast-enhanced CT of chest, abdomen and pelvis.**

التاريخ : **05-07-2026**	**الوقت :** **-- --:--**
	الطبيب المعالج : د/شيماء لاشين


جمهورية مصر العربية
بطاقة تحقيق الشخصية
منال
سعيد زين العابدين محمد
٢٨ش الخمسين-ابورجيله-النزهه ج
اول السلام - القاهره
٢ ٧٧ ٠٣ ٢٦ ٠١ ٠٤٤ ٠٦
IY7651540


٢٧٧٠٣٢٦٠١٠٤٤٠٦
٢٠٢١/٠٧
حاصلة على ليسانس آداب
أنثى مسلمة متزوجة
عصام احمد مصطفى محمد الشافعى
البطاقة سارية حتى ٢٠٢٨/٠٧/١٢

Name: منال سعيد زين العابدين **MR. :** 224	

Detailed Medical Report

السيد

تحية طيبة وبعد,,

إيماء للطلب المقدم من		**بشأن تقرير طبي للمريض**	
بقسم:		**رقم طبي:**	

ننشرف بأن نوضح فيما يلي تقريرا عن حالته

تاريخ وساعة الدخول :		**تاريخ وساعة الخروج :**	

وبعد الكشف والفحوصات والمتابعة وجد انه

The patient presented for initiation of arimidex, zoladex 10.8 mg, and zoledronic acid (Zometa) with a plan for a CT scan of the chest, abdomen, and pelvis and supportive therapy for three months.

The patient has a history of left breast cancer with oligometastatic bone disease involving the right femur (ER 5/8, PR 5/8, HER2-negative). She underwent a left mastectomy in April 2024 (pT2, N3). She has been on aromatase inhibitor therapy (zoladex AI) since October 2024. New baseline scans in June 2026 were free of disease, but a subsequent CT in June 2026 revealed a tiny 3 mm hepatic focal lesion. A dynamic MRI of the liver was ordered for a new suspicious lesion, and the patient was started on zoladex, zoledronic acid, and arimidex.

In August 2026, an MRI of the liver showed a hepatic focal lesion with hemorrhagic features. The patient was started on arimidex with supportive care for three months, with the next visit scheduled for 5 November 2026.

تحريرا في ,

التاريخ :	**20-09-2026**	**الوقت :**	

الطبيب المعالج : شريف الشناوى

يعتمد ,

Cairo University
National Cancer Institute
Department of Diagnostic and
Interventional Radiology

جامعة القاهرة
المعهد القومي للأورام
قسم الأشعة التشخيصية والتداخلية

Exam Information:

Patient Name: *MANAL SAID ZAIN*	***Date of birth:*** *01/01/1978*
Arabic Name: منال سعيد زين	***Patient Gender:*** *F*
Patient RIS ID: *374950* ***Patient HIS ID:*** *102000789*	***Exam Date:*** *14/09/2025*
Written by: DR.RANDA ALI	**Approved by:** DR.RANDA ALI

^{99m}Tc MDP Bone Scan Report (14/09/2025)

* Whole Body Anterior and Posterior Planar Views Acquired 2Hrs. Post I.V Injection of 20mCi of ^{99m}Tc MDP

Revealed:

Compared to the previous bone scan study dated (03/09/2024) the current study reveals:

- **Resolution** of the previously detected metastatic osseous deposit seen at right femoral sub-trochanteric region.
- Still seen warm focal tracer uptake at right 1st rib anteriorly.
- Degenerative changes are noted over the dorso-lumbar vertebrae.
- Arthritic changes are noted over both shoulder and both knee joints.
- Both kidneys are visualized.

Conclusion:

Follow up bone scan shows:

- Resolution of the previously detected right femoral sub-trochanteric metastatic osseous deposit.
- Stationary course of the previously detected right 1st rib osseous lesion.

Patient Name	: منال سعيد زين العابدين محمد الأستاذه	Request No.	: 13009679
Patient No.	: 27703260104406	Request Date	: 01/07/2024
Path No.	: SR-868/24	Verification Date	: 07/07/2024
Sex	: Female	Financial Category	: اورام دار السلام - نفقة الدولة
Age	: 47 Y	Department	: Out Patient
Referreing Doc :		Registered by	: .marwa mohamed youss

! athology Report

Clinical data
Left breast mass

Nature of specimen
Block &slide revision

Gross examination
One block &5 slides were received

Microscopic examination
* Histological type: Invasive duct carci oma.
* Grade (differentiation +nuclear pleon orphism+ mitosis): (3+3+2) Grade III
* DCIS: No
* Angioinvasion: Couldn't be detected. the received biopsy
*Perineural invasion: No
*Lymph nodes : Positive (10/10)
*Margins : infitrating the submitted mu cle

Diagnosis
Left breast mass, MRM, Slide revision
Invasive duct carcinoma, Grade III
-Infitrating the submitted muscle
-All lymph nodes were positive (10/10)
For further IHC (ER, PR, HER2, Ki67)

Signature
Dr. Ra a Fathy
Dr.He a Hassan

Verified by :

غرفة رقم (4) – الدور الأول – مبنى رقم (987) – كورنيش النيل – مصر القديمة – القاهرة – مصر
Room No. (4) - First Fl or-Building No. 987- Nile Corniche - Misr ELQadema - Cairo, Egypt

Pathology Report
[[DOCTYPE:PATHOLOGY_REPORT]]

GUSTAVE ROUSSY
INTERNATIONAL
EGYPT

Patient Name: Manal Saeed Zein Al Abedin	Date : 02/11/2025
Exam : CT CAP+C (CT Chest Abd. Pelvis)	Age : 48 Year(s)
Medical ID: 2024/2024	Pat. ID: 99120

POST CONTRAST MULTI-SLICE CT SCAN OF THE CHEST, ABDOMEN, AND PELVIS: -

Compared to last study dated 10/5/2025

Findings:

I Chest:-

- Status post left MRM showing clear operative bed.
- Clear right breast.
- No suspicious axillary lymph nodes.
- No sizable pulmonary nodules, masses, areas of consolidation or cavitary lesions.
- No hilar or mediastinal lymph nodes.
- No evidence of pleural effusion, pleural thickening or masses seen.
- Normal cardiac size and shape with no gross abnormality of the cardiac chambers. No pericardial effusion detected.
- Normal CT appearance of the thoracic aorta and the great vessels.

II Abdomen & pelvis:

- The liver is of average size with homogenous fatty CT texture. No definite enhancing focal lesions or contour irregularities.
- No intra-hepatic or extra-hepatic biliary radicles dilatation.
- Patent homogenously enhancing portal vein and is main branches as well as its main tributaries
- Normal size & parenchymal texture of the spleen with no focal lesions seen.
- Normal size, parenchymal thickness & density of both kidneys with no stones or back-pressure changes.

- Normal appearance of the pancreas, aorta, I.V.C and both suprarenals.
- Smooth filling of the urinary bladder with no filling defects or diverticular outpouching.
- Normal appearance of the other pelvic organs.
- No abdominal or pelvic masses or collections.

***Scanned skeleton: Still seen right femoral proximal shaft sclerotic lesion measuring 1.5 cm.**

Opinion:

- **Still noted right femoral proximal shaft sclerotic lesion of suspicious nature for bone scan.**
- **No evidence of pulmonary or hepatic metastatic deposits.**
- **Fatty liver.**
- **Stationary course since the last study.**

Dr. Mai Shaaban MD

Dr. Mai Shaaban

Dr. Mai Shaaban